

Gestão de Serviços de Farmácia

Flávia Deffert



Aula 04



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
EDUARDO NASCIMENTO DE ARRUDA

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

A Autora

FLÁVIA DEFFERT

Olá. Meu nome é Flávia Deffert. Sou formada em farmácia pela Universidade Federal do Paraná onde, também, cursei mestrado em Ciências Farmacêuticas. Após o mestrado, pude experimentar atividades administrativas e a docência. Como experiência profissional, trabalhei na FUNTEF no setor de compras – licitações, conhecimento que depois pude aplicar na atividade como farmacêutica na FUNEAS. Atuava na direção técnica dessa fundação que é responsável pela gestão administrativa de uma série de hospitais do Estado do Paraná. Na FUNEAS, realizei atividades relacionadas a seleção, programação e aquisição de insumos e medicamentos. Para auxiliar nessas atividades, iniciei uma Pós-Graduação lato sensu em Gestão por processos e da qualidade e outra em Gestão de Serviços de Saúde, ambas na FAE Business School. Também, atuei como professora de farmacotécnica e elementos de farmacologia para o curso de farmácia e para o curso técnico em podologia, na UnC Mafra/SC e FAFILTEC Curitiba. Assim, pude perceber o quanto eu adoro exercer a minha profissão e, assim, poder transmitir conhecimento e as minhas experiências para você, que está iniciando a sua profissão. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Iconográficos

Olá. Meu nome é **Manuela César de Arruda**. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Explorando a distribuição e dispensação de medicamentos	10
O que é e objetivos da distribuição e dispensação de medicamentos e produtos para saúde	10
Métodos de distribuição e dispensação e medicamentos	19
Farmacovigilância	27
Descobrimos tecnologias que auxiliam na distribuição e/ou dispensação de medicamentos	30
Tecnologia e serviços de farmácia	30
Dividir e conquistar	32
Os fins justificam os meios	35
Tecnologia da Informação e farmácia hospitalar	37
Aprendendo a gerir processos e qualidade: identificação de erros	41
Gestão por processos	42
Aprendendo a gerir processos e qualidade: ferramentas e soluções	49
O que é qualidade?	49
Controle x Garantia x Gestão	50

UNIDADE

04

INTRODUÇÃO

Olá pessoal! Chegou a hora de conhecermos as etapas de distribuição, dispensação e monitoramento dos medicamentos ou produtos para a saúde dentro do ciclo da assistência farmacêutica. Essas etapas constitui uma importante fase da garantia da segurança ao paciente já que erros na distribuição pode acarretar erros – paciente errado, medicamento errado, dose errada etc. que podem levar o agravo a saúde e até a morte do paciente. Para garantir a qualidade dos serviços de farmácia e facilitar a comunicação entre os setores do hospital com a farmácia e otimizar os processos tecnologias aplicadas a saúde podem ser empregadas. Assim, esse será outro assunto que iremos abordar. Por fim, conheceremos ferramentas de gerenciamento para a gestão por processos e da qualidade que promoverá maior segurança e qualidade prestados por você ao estabelecimento de saúde. Independente da área de atuação, as ferramentas da qualidade promovem maior conhecimento do processo e seu monitoramento para uma melhoria contínua da qualidade. Enfim, que tomemos o *kaizen* não só para o nosso trabalho, mas como uma filosofia de vida. E, aí? Prontos? Vamos lá.

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 4. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Explorar diferentes métodos de distribuição e dispensação de medicamentos;
2. Descobrir tecnologias inovadoras que auxiliam na distribuição e/ou dispensação de medicamentos;
3. Aprender a gerir processos e qualidade: identificação de erros;
4. Aprender a gerir processos e qualidade: ferramentas e soluções.

Esses objetivos me fazem lembrar... Einstein disse "Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne". Ao longo dessa unidade verá como essa frase e a gestão por processos e da qualidade estão alinhadas.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Explorando a distribuição e dispensação de medicamentos



INTRODUÇÃO:

Ao término dessa competência você entenderá como diferentes métodos de distribuição e dispensação de medicamentos tem influência nos custos e na segurança do paciente internado. Além disso, também saberá de que forma a rastreabilidade pode ser usada em benefício da farmacovigilância. Pode apostar que são coisas que facilitam a sua vida. E então? Vamos lá!!

O que é e objetivos da distribuição e dispensação de medicamentos e produtos para saúde

Vamos primeiro lembrar o conceito de farmácia hospitalar que segundo a SBRAFH (2017), é:

"A farmácia de hospitais, clínicas e estabelecimentos congêneres é uma unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital, adaptada e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente" (SBRAFH, 2017).

As responsabilidades da farmácia hospitalar, resumidamente, podem ser descritas como a gestão da assistência farmacêutica, gestão de produtos médico-hospitalares, implementação e monitorização de uma política interna de medicamento, gestão dos medicamentos empregados nos ensaios clínicos – se for o caso.

A SBRAFH (2017) resume as funções da farmácia hospitalar:

Na farmácia hospitalar e dos demais serviços de saúde, a provisão de produtos e serviços deve ser compreendida como meio, sendo a finalidade máxima do exercício de sua práxis o resultado da assistência prestada aos pacientes. Garantindo medicamentos seguros e necessários, quando estes são requeridos, visando sempre a efetividade da farmacoterapia e terapêutica geral, voltando-se também para o ensino e a pesquisa, propiciando assim um vasto campo de aprimoramento profissional. (SBRAFH, 2017).

Complementando, segundo a Resolução do CFF n. 568, de 6 de dezembro de 2012, que dá nova redação aos artigos 1º ao 6º da Resolução/CFF nº 492 de 26 de novembro de 2008, que regulamenta o exercício profissional nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada, define-se que:

"Art. 2º - Os serviços de atendimento pré-hospitalar, farmácia hospitalar e outros serviços de saúde, têm como principal objetivo contribuir no processo de cuidado à saúde, visando à melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente, promovendo o uso seguro e racional de medicamentos - incluindo os radio-fármacos e os gases medicinais - e outros produtos para saúde, nos planos assistencial, administrativo, tecnológico e científico".

O farmacêutico hospitalar deve garantir aos doentes os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos de melhor qualidade e aos mais baixos custos. A seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, a distribuição, a dispensação e o acompanhamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos devem ocorrer sob a tutela de um farmacêutico.

Essas ações são realizadas por meio de estudos fármaco-econômicos que, preferencialmente, não devem sofrer influência de preferências pessoais e não respaldadas em fatos científicos.

Essas etapas compõe a assistência farmacêutica que é definida como: um conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Esse conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2010).

Figura: Ciclo da assistência farmacêutica



Fonte: a autora (2019)

A distribuição e a dispensação de medicamentos são as duas últimas etapas do ciclo da assistência farmacêutica. Apesar de parecidos, esses dois conceitos trazem definições diferentes:

- Distribuição de medicamentos: uma das etapas do ciclo do medicamento nas dependências do hospital;

- Dispensação, segundo a Política Nacional de Medicamentos, é o ato em que o profissional de Farmácia ou farmacêutico busca fornecer medicamentos a um paciente, de maneira geral, como solução à apresentação de um receituário elaborado por um profissional que deve, para tanto, ser autorizado segundo as atuais leis vigente no país. Nesse

ato, o profissional farmacêutico informa, orienta e pode acompanhar o paciente sobre o uso adequado do medicamento.

Para o Ministério da Saúde, as características de um sistema de distribuição devem abranger:

- Rapidez: o processo de distribuição deve ser realizado em tempo hábil, mediante um cronograma estabelecido;
- Segurança: garantia de que os produtos chegarão ao destinatário nas quantidades corretas e com a qualidade desejada;
- Sistema de informação e controle: a distribuição deverá ser monitorada sempre, com sistema que apresente dados atualizados a cada instante sobre as quantidades recebidas e distribuídas, dos dados de consumo e da demanda de cada produto, dos estoques máximo e mínimo, do ponto de reposição, e qualquer outra informação que se fizer necessária para um gerenciamento adequado;
- Transporte Na escolha do transporte, devem-se considerar as condições adequadas de segurança, a distância das rotas das viagens, o tempo da entrega e os custos financeiros.

O intervalo de tempo entre as distribuições deve ser cuidadosamente observado, evitando-se o desabastecimento. Quanto menor a periodicidade, maiores os custos com a distribuição. A distribuição mensal, apesar de mais onerosa ao sistema, é a que garante o melhor acompanhamento e gerenciamento das informações.

O processo de distribuição deve consistir em algumas etapas que consistem em:

- Analisar a solicitação;
- Processar a solicitação;
- Preparar e liberar o pedido;
- Conferir;
- Registrar a saída;
- Liberar;
- Arquivar a documentação.

Ainda sobre a distribuição o Ministério da Saúde sugere que haja a avaliação constante do serviço prestado para que sejam identificados rapidamente pontos críticos que exijam ações corretivas. Como indicadores sugere-se:

- Percentual e (ou) número de unidades atendidas mês/ano.
- Tempo médio gasto na reposição dos medicamentos.
- Percentual de unidades de saúde atendidas de acordo com o cronograma de distribuição.
- Percentual de demanda atendida e não atendida.
- Percentual de itens solicitados X itens atendidos.
- Percentual do gasto mensal com medicamentos para atender à atenção básica de saúde e por unidade de serviço

Já, a dispensação, como já vimos, é definida como "o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, em resposta a apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado". É importante que haja ênfase no cumprimento da dosagem, a influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de conservação dos produtos.

Segundo, ainda, o Ministério da Saúde, os objetivos da dispensação são: educar para o uso correto do medicamento; contribuir para o cumprimento da prescrição médica; proporcionar uma atenção farmacêutica de qualidade; garantir o fornecimento do medicamento correto e na quantidade adequada. Para isso é importante que o profissional apresente algumas características como ter empatia, saber comunicar-se, ser paciente, saber ouvir, e ter técnicas de persuasão para o correto cumprimento do prescrito.

A portaria 4283/2010, o Ministério da Saúde descreve a importância da distribuição e dispensação:

A implantação de um sistema racional de distribuição de medicamentos e de outros produtos para a saúde deve ser priorizada pelo estabelecimento de saúde e pelo farmacêutico, de forma a buscar processos que garantam a segurança do paciente, a orientação necessária ao uso racional do medicamento, sendo recomendada a adoção do sistema individual ou unitário de dispensação. No contexto da segurança, a avaliação farmacêutica das prescrições, deve priorizar aquelas que contenham antimicrobianos

e medicamentos potencialmente perigosos, observando concentração, viabilidade, compatibilidade físico-química e farmacológica dos componentes, dose, dosagem, forma farmacêutica, via e horários de administração, devendo ser realizada antes do início da dispensação e manipulação. Com base nos dados da prescrição, devem ser registrados os cálculos necessários ao atendimento da mesma, ou à manipulação da formulação prescrita, observando a aplicação dos fatores de conversão, correção e equivalência, quando aplicável, sendo apostos e assinado pelo farmacêutico.

São responsabilidades do farmacêutico a análise da prescrição, identificar as necessidades do paciente, manter-se atualizado, cumprir a legislação, manter os registros adequadamente preenchidos, cumprir com a farmacovigilância, orientar o usuário e/ou a equipe de saúde, orientar quanto o transporte e armazenamento dos medicamentos e avaliar as atividades do pessoal de apoio.

Os seguintes indicadores são sugeridos para o acompanhamento do desempenho do processo de dispensação:

- Número de prescrições dia/mês;
- Percentual de prescrições atendidas e não atendidas.
- Número de prescrições por: especialidade médica, sexo, faixa etária. Medicamentos mais prescritos.
- Percentual de prescrições em desacordo com as normas estabelecidas.
- Número de itens de medicamentos atendidos por prescrição.
- Número de pacientes atendidos ou percentuais de cobertura.
- Número de notificações de reações adversas.



REFLITA:

Lendo essas descrições, você percebeu como no ambiente hospitalar essas duas atividades, na verdade, se confundem? Vimos que o paciente deve estar em primeiro lugar, certo? Mas, no hospital, a medicação não é dispensada diretamente para o paciente, não é?

Agora por que se começou a buscar novas possibilidades de distribuição de medicamentos?

- 1950 – Primeiros registros de erros de medicação- uma a cada seis doses administrada estava errada

Algumas causas comuns dos erros são:

- má grafia médica na prescrição, que não permite a correta identificação da substância e/ou dosagem;

- diferentes modos de prescrever e de escrever as dosagens, usando sistemas de pesos e medidas variáveis;

- prescrições que não utilizam o nome da substância conforme preconizado e sim o nome fantasia;

- precário sistema de comunicação, o que dificulta a troca de informações entre as equipes de enfermagem, como alteração de doses ou suspensão de medicação;

- falta de informação sobre os medicamentos, como estabilidade, forma adequada de armazenamento, diluição e preparo.

Erros de medicação são a administração do medicamento dose, forma ou via errada, na hora errada, a falta da administração ou a administração em duplicidade, a administração de medicamentos deteriorados, vencidos, reconstituídos ou preparados de maneira incorreta. De forma a tornar mais fácil a obtenção de uma administração correta, foram estabelecidos a regra dos "9 certos", bastante conhecido pelos profissionais da enfermagem. Em especial, porque são os responsáveis pela administração. Os nove certos são:

1. Medicação certa
2. Paciente certo
3. Dose certa
4. Via certa
5. Horário certo
6. Registro certo
7. Ação certa
8. Forma farmacêutica certa
9. Monitoramento certo

Em estudos realizados nos Estados Unidos, verificou-se que 31% estavam relacionados à equipe de enfermagem, 24% à farmácia e 13% à

equipe médica. Dessa forma, conclui-se que o farmacêutico hospitalar, também, possui papel fundamental no desenvolvimento e, também, na implantação de processos que possam prevenir os erros com medicações. Autores classificam os tipos de erros de medicação como:

- a. Erros de prescrição: escolha incorreta do medicamento, doses inadequadas, via de administração e velocidade de infusão erradas, além de prescrições ilegíveis;
- b. Erro de horário: administração fora do tempo correto;
- c. Erro de dispensação: erros de conteúdo, rotulagem e documentação;
- d. Erro de administração: dose, horário, paciente, diluição etc.

Além disso, outros fatores, como estresse, fadiga e distrações, que podem levar a erros, uma vez que muitos profissionais da área da saúde conciliam diversas cargas horárias de trabalho em diferentes hospitais. Algumas estratégias podem ser utilizadas para minimizar erros medicamentosos:

- a. Padronização de processos e efetiva atuação da Comissão de Farmácia e Terapêutica
- b. Protocolos formais para rotinas e dos processos.
- c. Simplificação dos processos e das rotinas.
- d. Educação continuada
- e. Não confiar cegamente na memória (podem ocorrer "lapsos de memória").
- f. Reduzir improvisos e mudanças de turno de trabalho.
- g. Estimular a automação de todos os processos com toda a equipe de saúde

O farmacêutico hospitalar deverá preparar-se para atuar com excelência no processo de distribuição e dispensação hospitalar. Para tanto se faz necessário que desenvolva competências técnicas, gerenciais, clínicas e humanísticas. Suas competências nas áreas de logística, farmácia clínica, atenção farmacêutica, faturamento, farmacoeconomia, farmacotécnica, farmacologia, farmacovigilância, gestão da qualidade, tecnologia da informação, automação hospitalar e gestão de estoques devem ser aprimoradas.

Ao final de seus estudos, esse profissional deve estar apto à:

- Escolher, implantar e utilizar softwares de controle de estoques, prescrição eletrônica, prontuário eletrônico do paciente, sistemas: enterprise resourcing planning (Erp), data warehouse (dW), electronic data interchange (Edi), dentre outros recursos de TI;

- Escolher, implantar e utilizar recursos de automação como equipamentos para fracionamento, unitarização, reembalagem e mistura de medicamentos, equipamentos para separação e distribuição de medicamentos (robôs, esteiras, elevadores monta-carga, tubos pneumáticos, carrinhos automatizados), armários automatizados, etiquetas que possibilitem a rastreabilidade: código de barras (lineares EAN13 e GS1-128, bidimensionais – dataBar e dataMatrix); magnéticos; e, etiquetas *radio frequency identification* (rfid);

- Avaliar qual sistema de distribuição de medicamentos é o mais adequado para o hospital;

- Implantar e desenvolver o sistema de distribuição de medicamentos escolhido;

- Considerar a necessidade de haver farmácias satélites (distribuição descentralizada);

- Considerar a dispensação de MED/MAT na forma de kits;

- Determinar formas adequadas de acondicionar, identificar e diferenciar os MED/MAT para garantir a conservação dos produtos;

- Realizar a logística reversa dos MED/MAT devolvidos das unidades assistenciais para a farmácia;

- Elegar e aplicar ferramentas de gestão da qualidade na gestão dos processos de dispensação e distribuição de MED/MAT, como ciclo PDCA, *failure mode and effects analysis* (fMEA), diagramas de Pareto e Ishikawa;

- Analisar as prescrições de medicamentos e requisições de materiais.

Além disso, é importante a escolha de um método de distribuição adequado, que permita rastrear e confirmar a medicação a cada etapa até a administração e monitoramento.

Métodos de distribuição e dispensação e medicamentos

Os processos de dispensação e distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares são dois dos principais processos relativos à assistência farmacêutica em âmbito hospitalar. Cada um desses processos é composto por uma série de atividades interrelacionadas e possuem grande importância financeira, operacional e assistencial.

Assim, como já vimos, cada atividade relativa à dispensação e à distribuição deve ser controlável, rápida, econômica e segura, pois falhas nessas atividades podem ocasionar danos aos pacientes e perdas financeiras para o hospital, afetando o desempenho e a imagem da instituição. Um sistema de distribuição de medicamentos deve ser racional, eficiente, econômico, seguro e deve estar de acordo com o esquema terapêutico prescrito. Quanto maior a eficácia do sistema de distribuição, mais garantido será o sucesso da terapêutica e da profilaxia instauradas no hospital.

A escolha do sistema de distribuição de medicamentos deve se basear nas características do hospital, para atender ao paciente internado com segurança, qualidade e economia. O sistema escolhido deve ser racional, eficiente, econômico e seguro. É importante observar características como:

1. Tipo do hospital: público ou privado;
2. Característica do serviço prestado pelo hospital: hospital geral ou especializado;
3. Recursos humanos, materiais e econômicos disponíveis no hospital.

Para que o sistema seja eficaz e racional, é necessário considerar o controle de estoque, a padronização de medicamentos, a presença de recursos humanos bem treinados e capacitados no setor e a garantia e o controle da qualidade dos processos existentes na farmácia.

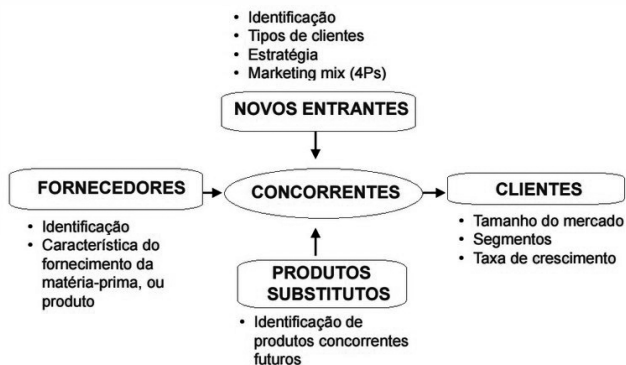
Para a Organização Pan Americana de Saúde, os objetivos dos sistemas de dispensação de medicamentos devem ser: reduzir os erros de medicação, aumentar o controle sobre os medicamentos, reduzir os custos com medicamentos, promover a racionalização da distribuição, aumentar a segurança para os pacientes.

Alguns aspectos devem ser observados para que o sistema de distribuição seja adequadamente escolhido, implantado e desenvolvido:

■ Aspectos administrativos: o setor de compras deve estar envolvido no processo para garantir o estoque, manter a eficiência e a racionalidade na distribuição. Os recursos humanos envolvidos devem estar aptos, ou seja, devidamente treinados.

■ Aspectos econômicos e políticos: o farmacêutico deve estar atento à posição econômica e políticos em que o país se encontra, como também, realizar a análise do ambiente externo e interno por fatores que possam interferir no fornecimento de algum medicamento, por exemplo. Uma boa ferramenta para realizar esse tipo de análise é a matriz SWOT ou, em português, FOFA: forças e fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo); e as 5 forças de Porter para a análise do ambiente externo – adaptada a realidade do serviço em saúde.

Figura 2: Esquema das 5 forças competitivas de Porter



Fonte: Wikimedia Commons

É importante que se elabore um projeto de implantação formal, isto é, por escrito, para que fique documentado e seja discutido e aprimorado conforme as necessidades do hospital. Deve-se lembrar que nessa etapa é essencial que os passos do ciclo PDCA sejam cumpridos adequadamente, pois, quanto mais se planeja, menor é o número de ações corretivas após a implantação.

Os tipos atualmente conhecidos de sistemas de distribuição de MED/MAT são:

- coletivo;
- individualizado (direto ou indireto);
- dose unitária;
- misto (quando, no mesmo hospital, adota-se mais de um tipo de sistema).

As vantagens e desvantagens de cada um está descrita na tabela, elaborada pela autora a partir de dados de Cavallini e Bisson, 2010.

Tabela 1: Relação das vantagens e desvantagens dos sistemas de distribuição coletivo, individualizado e dose unitária

	Coletivo	Individualizado	Dose unitária
Vantagens	facilidade de acesso aos medicamentos pouco volume de requisições à farmácia recursos humanos e infraestrutura da farmácia reduzidos ausência de investimento inicial.	redução de "estoques" nas unidades atendimento da medicação para 24 horas diminuição do número de erros de medicação possibilidade de devolução à farmácia do que não foi utilizado redução do tempo gasto pela enfermagem na separação dos medicamentos por paciente, mas precisa separar as doses; atuação do profissional farmacêutico.	ausência de estoques periféricos redução do potencial de erros de medicação atuação efetiva do profissional farmacêutico maior devolução dos medicamentos não administrados à farmácia - economia redução do tempo gasto pela enfermagem para separar medicação; redução de custos com medicamentos pelo maior controle de estoque e faturamento medicação dispensada em doses organizadas e higiênicas; maior segurança para o médico, para a enfermagem e, sobretudo, para o paciente
Desvantagens	ausência do farmacêutico na equipe de saúde minimas atividades de devolução à farmácia aumento do potencial de erros de medicação (doses, formas farmacêuticas, horários de administração etc.) perdas econômicas decorrentes da falta de controle de estoque, validade, contaminação, perda, roubo	potencial de erros com medicamentos ainda é alto o tempo gasto pela enfermagem para separar as dosagens por paciente falta de controle efetivo do estoque e faturamento.	aumento de recursos humanos e infraestrutura da farmácia investimento necessário ao início do sistema de distribuição e TI aumento das atividades na farmácia aquisição de materiais e equipamentos especializados

Fonte: autora, 2019

É importante lembrar que usualmente não há um único sistema de distribuição em toda a estrutura hospitalar. De acordo com o setor há uma necessidade de abastecimento diferente, por exemplo: centro cirúrgico e UTI. Agora vamos às características de cada um:

■ Sistema coletivo: esse sistema é o mais antigo e é tido como tradicional. Neste sistema, os medicamentos são distribuídos por unidade de internação, baseando-se em solicitações da enfermagem e normalmente de acordo com uma padronização preestabelecida entre a unidade e a farmácia. Ocorre a formação de vários estoques espalhados pelo hospital, que ficam sob a responsabilidade da enfermagem. Dessa forma, a farmácia funciona como mero distribuidor de medicamentos (almoxarifado), não obtendo informações sobre os pacientes que recebem as medicações, sobre a duração do tratamento ou sobre o motivo da prescrição.

Os principais problemas desse sistema de distribuição são os elevados índices de erro de medicação; o "desperdício de tempo" da enfermagem em realizar atividades como a transcrição das prescrições, armazenamento, controle de estoque e separação de dosagens, entre outras atividades; e, por fim, o alto custo gerado pelo alto índice de perda, de desvios, de armazenamento incorreto ou inadequado e de vencimento dos medicamentos nos estoques espalhados pelo hospital.

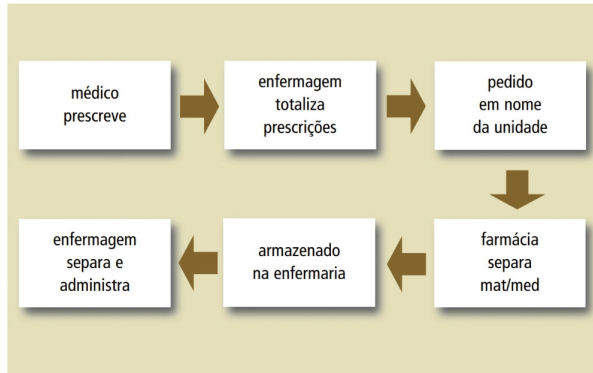
Assim, a ausência de investimento, que a princípio parece vantajosa, termina se refletindo em custos indiretos que podem ser irreversíveis do ponto de vista tanto econômico como técnico, comprometendo a qualidade, o controle e a segurança do esquema terapêutico oferecido ao paciente (Cavallini e Bisson, 2010).

O fluxograma de atividades desse tipo de sistema de distribuição é o seguinte:

1. O médico faz a prescrição;
2. A enfermagem transcreve as prescrições, reunindo as de todos os pacientes;
3. O pedido é encaminhado em nome da unidade (ou setor) apropriada;
4. A farmácia separa materiais e medicamentos em suas embalagens originais;

5. A enfermagem recebe o pedido e armazena os itens na enfermaria;
6. A enfermagem separa o pedido por paciente e por dose e a administra.

Figura 3: Representação esquemática do fluxograma de atividades do sistema de distribuição coletivo



SISTEMA COLETIVO

Fonte: Cavallini e Bisson, 2010

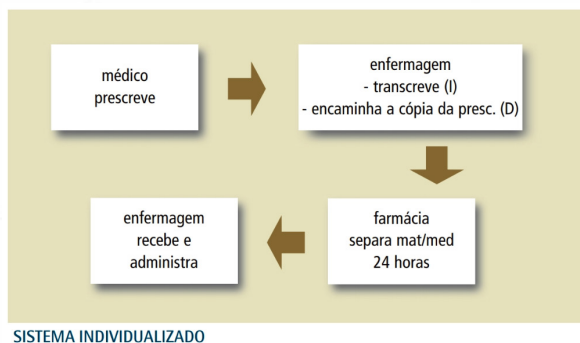
■ Sistema Individualizado: também é considerado um sistema de distribuição tradicional. Nesse sistema o medicamento é dispensado por paciente, de acordo com a prescrição médica, para um período determinado, normalmente por 24 horas. Pode ser direto (quando a solicitação é feita por meio do original ou da cópia direta da prescrição, quando ocorre uma discreta participação do farmacêutico, uma vez que as prescrições são avaliadas e revisadas) ou indireto (quando a solicitação é feita por meio da transcrição da prescrição, por paciente).

O fluxograma das atividades do sistema individualizado segue a seguinte ordem de atividades:

1. O médico faz a prescrição em duas vias ou prescreve em apenas uma via e a enfermagem a transcreve;
2. A farmácia recebe a prescrição médica (ou a cópia transcrita pela enfermagem);
3. A farmácia separa os materiais e medicamentos por paciente e leito (para um período de 24 horas), e sela os medicamentos e dá baixa no estoque;

4. O farmacêutico confere a prescrição e a separação dos itens, antes de encaminhá-los ao setor;
5. A enfermagem recebe as tiras seladas, contendo os medicamentos, e separa a dosagem a ser administrada ao paciente;
6. Depois de 24 horas, a enfermagem faz a devolução dos medicamentos não administrados.

Figura 4: Representação esquemática do fluxograma de atividades do sistema de distribuição individualizado



Fonte: Cavallini e Bisson, 2010

A evolução do sistema coletivo para o individualizado conta com um aumento de gasto em recursos humanos e de infraestrutura, aumento de atividades na farmácia hospitalar e o funcionamento ininterrupto da farmácia. Veja que esse gasto acaba se tornando em investimento, uma vez que a economia gerada pela adoção de um sistema de distribuição mais robusto paga, ao longo do tempo – conceito de tempo de *payback*, o valor inicialmente investido.

É importante frisar que o sistema individualizado é usado, muitas vezes, como uma etapa intermediária à adoção do sistema por dose unitária.

■ Sistema de distribuição por dose unitária: esse sistema é, atualmente, considerado como o melhor sistema de distribuição de MED/MAT. Foi desenvolvido na década de 1960 por farmacêuticos hospitalares americanos sendo o que oferece as melhores condições para o seguimento da terapia medicamentosa do paciente, além de ser mais eficiente e econômico para o estabelecimento hospitalar. Além disso, a dose unitária também reduz a incidência de erros medicamentosos, melhora a segurança na distribuição e na administração.

Os setores não apresentam estoques e todo medicamento, incluindo os de uso em caso de emergência, as soluções antissépticas e os de grande volume, são enviados para cada paciente, devendo ser devolvidos caso não sejam utilizados no período. Importante dizer que em setores como o pronto socorro, há um carrinho ou uma maleta de emergência, geralmente com um lacre numeral. Após o uso de algum de seus componentes, deve ser enviado o mais rápido possível para a reposição dos medicamentos faltantes e registro dos utilizados.

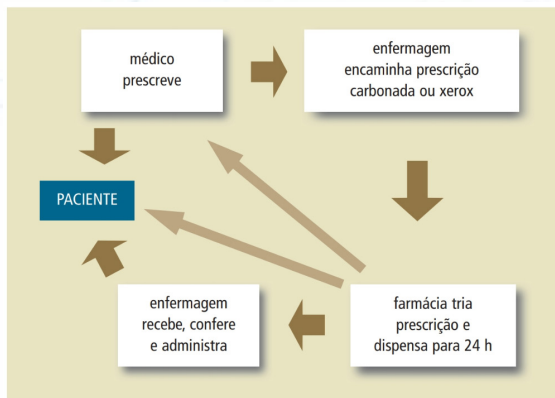
Outros autores descrevem esse sistema como aquele em que os medicamentos são dispensados unitariamente, nas doses certas, acondicionados em tiras plásticas lacradas com o nome e o leito do paciente, contendo o horário de administração ao paciente. Promovendo o encaminhamento da medicação para o paciente certo, na dose certa e no horário certo. Tendo como objetivos:

- racionalizar a terapêutica, diminuindo custos sem reduzir a qualidade da dispensação; e,
- garantir que os medicamentos prescritos cheguem ao paciente de forma segura e higiênica, garantindo a eficácia do esquema terapêutico prescrito.

As atividades listadas em formato de fluxograma para esse sistema de distribuição são:

1. O médico faz a prescrição;
2. A enfermagem encaminha a prescrição médica para a farmácia (uma possibilidade é a farmácia ter um mensageiro que recolha as prescrições em horário já combinado com a enfermagem); ou melhor ainda: sistemas automatizados;
3. A farmácia faz a triagem (análise dos horários de administração dos medicamentos, quantidade, doses etc.) da prescrição;
4. O farmacêutico analisa a prescrição;
5. O auxiliar de farmácia prepara a dose unitária;
6. O farmacêutico confere o trabalho do auxiliar;
7. As tiras de medicamentos são encaminhadas à enfermagem, pelo mensageiro;
8. A enfermagem recebe as tiras de cada paciente, confere a medicação e a administra

Figura 5: Representação esquemática do fluxograma de atividades do sistema de distribuição por dose unitária



DOSE UNITÁRIA

Fonte: Cavallini e Bisson, 2010

É importante observar que o ideal é a dispensação de acordo com a necessidade, mas não sendo possível, deve-se empregar períodos. Por exemplo: manhã, tarde e noite.

Além disso, o farmacêutico, obrigatoriamente, deve fazer a última conferência das tiras lacradas, antes de encaminhá-las à enfermagem; assim, possibilita-se a análise da prescrição, garantindo-se dosagens corretas, diminuição de interações medicamentosas e adequação do horário de melhor absorção dos medicamentos ao paciente.

É imprescindível que as equipes de farmácia e enfermagem estejam trabalhando em consonância para que o maior beneficiado seja o paciente. As tiras, antes da administração, devem ser conferidas pela enfermagem, de preferência por sistema automatizado à beira do leito, e, se possível, pelo paciente.

Por fim, é importante entender o sistema de distribuição por dose unitária como uma linha de produção em que todos os passos são acompanhados, controlados e conferidos pelo farmacêutico, garantindo a eficiência operativa e a segurança do paciente.

Todos os sistemas de distribuição de medicamentos e materiais médicos apresentam vantagens e desvantagens. Contudo, como conversamos inicialmente, é importante que o farmacêutico junto a equipe multiprofissional das comissões de farmácia e terapêutica verifiquem a

necessidade real de cada setor do hospital, adaptando essa necessidade ao que for economicamente viável e prático para o hospital como um todo.

Farmacovigilância

Após a dispensação de medicamentos é necessário realizar a monitorização do tratamento junto ao paciente para verificar a ocorrência de qualquer reação ou evento adverso que direta ou indiretamente (mesmo que por uma remota chance) possa estar correlacionada ao medicamento ou qualquer produto empregado para o tratamento do paciente. Com o intuito de estudar esses eventos um ramo da ciência denominado de farmacovigilância foi criado.

Segundo a ANVISA, farmacovigilância é definida como "a ciência e atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados ao uso de medicamentos". A farmacovigilância se preocupa com reações adversas, eventos adversos causados por desvios da qualidade de medicamentos, inefetividade terapêutica, erros de medicação, uso de medicamentos para indicações não aprovadas no registro, uso abusivo, intoxicações e interações medicamentosas.

A importância da farmacovigilância pode ser explicada pela tragédia da talidomida ocorrida entre o final dos anos 50 e início dos 60. A talidomida foi posta no mercado como uma solução definitiva para as náuseas matinais das mulheres grávidas. No entanto, mais tarde, com o nascimento dos bebês... verificou-se que tinha efeitos deletérios no DNA causando más formações motoras que eram caracterizadas por um tipo peculiar de malformação congênita, causado pelo desenvolvimento defeituoso dos ossos longos dos braços e pernas e das mãos e pés. Dessa forma, parafraseando a Organização Mundial de Saúde (2005):

"a monitorização da segurança de medicamentos é elemento essencial para o uso efetivo de medicamentos e para a assistência médica de alta qualidade. Ela tem a capacidade de inspirar segurança e confiança de pacientes e profissionais da saúde em relação aos medicamentos e contribui para elevar os padrões da prática médica".

A Organização Mundial da Saúde explica que a farmacovigilância efetiva compreende um conjunto de regras, procedimentos operacionais e práticas estabelecidas que devem ser cumpridas a fim de assegurar a qualidade e a integridade dos dados produzidos em determinados tipos de pesquisas ou estudos. A atividade final da farmacovigilância consiste na aquisição de dados completos dos relatórios espontâneos de eventos adversos, ou seja, na notificação de casos.

A garantia da qualidade, segurança e eficácia também é um dos requisitos estabelecidos pela Política Nacional de Medicamentos. Esse processo fundamenta-se no cumprimento da regulamentação sanitária, destacando-se as atividades de inspeção e fiscalização, com as quais é feita a verificação regular e sistemática. Segundo a ANVISA, um sistema de farmacovigilância deve ser capaz de identificar possíveis problemas relacionados ao uso de medicamentos de forma efetiva e oportuna, a fim de prevenir ou minimizar eventuais danos à saúde dos indivíduos

A farmacovigilância é amparada pelas leis e resoluções: Lei Federal nº 6360/76, a Lei Federal nº 9782/99, a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 3/89 e a Portaria do Ministério da Saúde 3916/98. Além da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 04, Instrução Normativa (IN) nº 14 e RDC 36/2013.

As notificações que inicialmente eram classificadas em busca ativa e voluntária. A primeira é resultado da procura ativa pelas relações feitas com dados primários em que há o objetivo de provar a existência da reação ou problema de saúde. A segunda refere-se à notificação voluntária de suspeitas de reações ou eventos adversos, interações medicamentosas etc.

A partir da RDC 36/2013 em que foram estabelecidas as ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. Segurança do paciente é conceituado como redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. Nessa resolução torna-se compulsória a notificação de qualquer reação ou evento adverso ocorrido em instituição de saúde

O capítulo III, da resolução 36/2013, tem a redação para a vigilância, o monitoramento e a notificação de eventos adversos. O monitoramento dos incidentes e eventos adversos devem ser informados ao Núcleo de Segurança Paciente em até 72 h para os casos que evoluíram à morte e até o 15º dia do mês subsequente.

Cabendo à ANVISA: monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos serviços de saúde; divulgar relatório anual sobre eventos adversos com a análise das notificações realizadas pelos serviços de saúde; acompanhar, junto às vigilâncias sanitárias distrital, estadual e municipal as investigações sobre os eventos adversos que evoluíram para óbito.

Por fim, as notificações podem ser realizadas por qualquer pessoa, são obrigatórias aos profissionais de saúde em ocasiões que o paciente se encontra dentro de uma instituição de saúde. Também é compulsória às empresas que possuam registro no Ministério da Saúde que apresentam obrigatoriedade de reportar todas as situações em que seus medicamentos ou qualquer outro produto para saúde esteja envolvido.

A distribuição e a dispensação além de funções administrativas também abordam situações de atendimento clínico farmacêutico. O ideal é que esse profissional possa e seja capacitado a avaliar a farmacoterapia e acompanhar de perto os pacientes. Esse monitoramento é importante para garantir que o tratamento esteja ocorrendo conforme o previsto e esteja havendo uma melhoria na condição de saúde do paciente.

RESUMINDO:

E então? Conseguiu perceber como os sistemas de distribuição podem afetar de modos diversos a economia financeira do hospital e, sobretudo, a segurança do paciente? Vamos relemburar alguns tópicos que abordamos. Inicialmente, vimos a diferenciação conceitual entre distribuição e dispensação de medicamentos e, também, concluímos que no ambiente hospitalar essas duas atividades convergem. Também, descobrimos quais competências necessárias para o farmacêutico hospitalar que irá atuar diretamente na escolha do sistema de distribuição de MED/MAT. Vimos o que são erros medicamentosos, sua classificação e como evitá-los. Por fim, estudamos os diferentes tipos de sistema de distribuição de medicamentos, suas vantagens e desvantagens, características individuais e fluxograma de atividades. UFA! Dê uma respiradinha. Caso ocorra algum RAM, você faz o que? Notifica a ANVISA pelo NOTIVISA Pronto para a próxima? Vamos lá!



Descobrimos tecnologias que auxiliam na distribuição e/ou dispensação de medicamentos



INTRODUÇÃO:

Olá pessoal! Tudo bem com você? A nossa jornada por essa nova competência promete, ein! Ao final dessa competência você conhecerá técnicas antigas e novas que auxiliam no dia a dia dos serviços farmacêuticos. Você imaginou o tempo que te economizaria se uma máquina fizesse o controle de estoque pela leitura dos códigos de barra as embalagens diretamente nas prateleiras de armazenamento? Que tal robôs com braços mecânicos que localizam e entregam o produto necessário? E a rastreabilidade de medicamentos feita por radiofrequência? Módulos de sistemas de TI com comunicação direta com o serviço de farmacovigilância da ANVISA? Sistemas baseados em inteligência artificial que montem os kits de acordo com as prescrições? Tecnologias mais antigas que permitem a prescrição eletrônica e a formação de polos de distribuição dentro da instituição de saúde também são importante e serão vistas! Pronto para sanar todas as suas curiosidades sobre tecnologia? Vamos descobrir!!

Tecnologia e serviços de farmácia

Ao contrário do que possamos pensar, tecnologia não é só aquilo que envolve um sistema informatizado ou um robô.

Tecnologia é definida pelo dicionário Michaelis como:

tec·no·lo·gi·a (sf)

1. Conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativos à arte, indústria, educação etc.: "O ensaio me pareceu muito bem craniado. Só notei que estás demasiadamente fascinado pela tecnologia. Daí a aceitar sem reservas a tecnocracia é um passo muito curto" (EV).

2. Conhecimento técnico e científico e suas aplicações a um campo particular: "Os serviços de informação e inteligência do Departamento de Estado norte-americano já dispunham de tecnologia suficiente para rastrear o encontro num quarto de hospital de dois personagens secundários [...]" (CA).

3. POR EXT Tudo o que é novo em matéria de conhecimento técnico e científico.
4. Linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento, teórico ou prático.
5. Aplicação dos conhecimentos científicos à produção em geral: Vivemos o momento da grande tecnologia.

Assim, podemos concluir que a implantação de uma tecnologia em saúde pode custar zero reais a instituição e, ainda assim cumprir com a sua função. Lembre-se que a farmácia deve ter suas ações focadas no cliente; então, a implantação de uma tecnologia em saúde influencia diretamente na promoção e recuperação da saúde do paciente.

Segundo Malagón-Londoño (2019), *as tecnologias mais avançadas proporcionam alta efetividade em prevenção, detecção, análise e tratamento de doenças, aumentando a expectativa de vida e, consequentemente, diminuindo a incidência de mortes prematuras.*

Sobre o assunto, por meio da portaria n. 4283/2010, foram estabelecidas diretrizes para o aprimoramento e o fortalecimento de ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais, fica estabelecido no item 4.3 – da gestão da informação, infraestrutura e tecnologia:

A gestão da informação reveste-se de fundamental importância no desenvolvimento das atividades da farmácia hospitalar, devendo-se empreender esforços para possibilitar a sua realização.

A infraestrutura física e tecnológica é entendida como a base necessária ao pleno desenvolvimento das atividades da farmácia hospitalar, sendo um fator determinante para o desenvolvimento da assistência farmacêutica, devendo ser mantidas em condições adequadas de funcionamento e segurança. A infraestrutura física para a realização das atividades farmacêuticas deve ser compatível com as atividades desenvolvidas, atendendo às normas vigentes.

A localização da farmácia deve facilitar o abastecimento e a provisão de insumos e serviços aos pacientes, devendo contar

com meios de transporte internos e externos adequados, em quantidade e qualidade à atividade, de forma a preservar a integridade dos medicamentos e demais produtos para a saúde, bem como a saúde dos trabalhadores. (Portaria 4283/2010, Ministério da Saúde, anexo, item 4.3)

Importante é lembrar que a tecnologia de ponta está aplicada no dia a dia dos profissionais de saúde que trabalham, principalmente, com a detecção de problemas de saúde. Enquanto as atividades administrativas, mesmo as intimamente relacionadas à própria assistência ao paciente, é rudimentar.

Ainda por meio da portaria 4283/2010, o Ministério da Saúde informa que dentre as atividades que podem ser desenvolvidas pela farmácia, destaca-se o gerenciamento de tecnologias. Para o MS, a farmácia hospitalar deve participar do gerenciamento de tecnologias, englobando a qualificação de fornecedores, armazenamento, distribuição, dispensação e controle dos medicamentos, outros produtos para a saúde, produtos de higiene e saneantes usados pelos pacientes, em atendimento pré-hospitalar, pré-hospitalar de urgência e emergência, hospitalar (internamento e ambulatorial) e domiciliar, bem como pelo fracionamento e preparo de medicamentos.

Ainda, o Ministério da Saúde nos lembra que a tomada de decisões deve, sempre que possível, ter característica e envolvimento multidisciplinar. Isso se deve a maior probabilidade de adesão as políticas estabelecidas quando há o envolvimento de profissionais das diferentes áreas.

Dividir e conquistar

Uma estratégia que deve ser explorada e muito bem planejada para uma distribuição e dispensação de medicamentos de forma mais eficaz é a criação de farmácias satélite que se especializam em atender um determinado setor do hospital.

Alguns desses setores apresentam características únicas que diferem do restante da instituição. Por exemplo: o ambulatório atende consultas eletivas e realiza pequenos procedimentos como a troca de curativos caso

se faça necessário; porém, no pronto-socorro, em atendimentos de urgência e emergência, as situações que podem atravessar a porta do hospital são muito diferentes – desde um acidente de carro em que o paciente quebrou o braço, até acidentes com vítimas politraumatizadas. Outro local que apresenta características únicas é a unidade de terapia intensiva onde os pacientes internados, em geral, correm risco de morte.

Cavallini e Bisson (2010) explicam que esses setores se distinguem entre si devido aos aspectos:

- Presença de estoque e falta de controle do mesmo
- Locais em que há consumo simultâneo de materiais e medicamentos
- O custo unitário do produto utilizado é alto
- Apresentam itens que necessitam de cuidados de armazenamento, como controle da pressão.

Dessa forma, nesses locais há a necessidade de um controle e uma organização mais efetivos para manterem-se saudáveis, criando a necessidade de uma farmácia-satélite.

Farmácia-satélite é definida como uma farmácia localizada no próprio setor da dispensação com a finalidade de estocar adequadamente materiais e medicamentos e de proporcionar assistência farmacêutica efetiva e direta (Cavallini e Bisson, 2010).

Para a implantação da farmácia-satélite, o farmacêutico deve visitar o setor onde será implantada, para conhecer e acompanhar a rotina e, posteriormente, fazer um projeto de melhoria e adequação da área., segundo Cavallini e Bisson (2010).

Aqui vão alguns exemplos de farmácia satélite:

- Farmácia satélite de um centro cirúrgico: organiza e armazena o material e medicamento necessário para a execução de cirurgias. Abastecida dos medicamentos e dos produtos para a saúde, a farmácia satélite organiza carros de emergência e os kits de materiais para cada cirurgia ou procedimento, tais como kit laparotomia exploratória, kit histerectomia, kit anestesia geral, ...

Nos kits elaborados pela farmácia deve haver um checklist com campos que permita ao farmacêutico checar o dispensado, ao enfermeiro ou auxiliar marcar a conferência antes da cirurgia e após

a finalização dela. Essa instrução auxilia na garantia da segurança do paciente – para não correr o risco de “esquecimento de objetos” dentro da pessoa. Além disso, deve contar o nome do paciente, horário da cirurgia, no dos médicos principal e auxiliar.

O tamanho e a capacidade, bem como os itens a serem disponibilizados devem ser analisados conforme o tipo e a quantidade do serviço prestado no setor. A farmácia-satélite deve ter acesso ao mapa cirúrgico de modo que de antemão possa organizar os kits a serem usados.

Após a realização da cirurgia, o farmacêutico realiza a conferência do material utilizado para que seja, só então, seja registrado e cobrado do paciente o que foi efetivamente utilizado.

Cavallini e Bisson (2010) nos informam que as vantagens de instalar uma farmácia-satélite em um centro cirúrgico são:

- racionalização do estoque;
- redução do desperdício;
- salas cirúrgicas sem estoques;
- melhoria do faturamento;
- redução de contaminação cruzada
- menor circulação de pessoas;
- interação entre as equipes multiprofissionais;
- efetiva assistência farmacêutica;
- controle e acesso à produtividade por meio de relatórios de

indicadores de eficiência.



ACESSE:

Para conhecer mais sobre esse assunto e como alinhar a filosofia lean, estude: <http://bit.ly/39Zw4wc>

A organização do serviço de farmácia em farmácias satélite promove maior eficiência na entrega dos medicamentos e produtos para saúde, além de diminuir desperdícios e efetivamente melhorar a lucratividade das operações.

Os fins justificam os meios

Partindo da frase atribuída à Maquiavel, vamos ver como alterações em métodos e meios da realização de atividades pode melhorar ou piorar a assistência ao paciente.

Primeiro, vamos falar de algumas ferramentas que não custam absolutamente nada, fora o tempo e o conhecimento do gestor. *Existem vários modelos de melhoria de desempenho formalizados disponíveis, e os sistemas de saúde costumam adotar uma metodologia particular, estabelecer recursos e estruturas de relatórios, e exigem o uso de tais recursos pelos líderes* (Allen et al, 2016).

Algumas metodologias para melhorar o desempenho são o ciclo PDCA, o *lean manufacturing* e o Six Sigma.

Inicialmente, o *lean manufacturing* (manufatura enxuta) ou Sistema Toyota de Produção consiste em uma filosofia/metodologia para a gerência de produção. Apesar de ter surgido no chão de fábrica, o lean pode ser aplicado aos setores de serviço. Ela consiste em uma tecnologia/filosofia que reduz o tempo entre a requisição de um produto e a chegada desse produto para o cliente final por meio da eliminação de perdas e desperdícios. A partir da sua aplicação na área de saúde, passou a ser denominado de *lean healthcare*.

Allen et al (2016) explicam que:

"No método Lean, a ideia é identificar um fluxo de valor particular ou processo e remover etapas desperdiçadas no fluxo de trabalho, criando uma menor variação e um ótimo resultado. Método Lean também requer treinamento especializado e compromisso significativo da organização para a implementação; no entanto, os ganhos provenientes dessas metodologias podem ser significativos."

Os desperdícios a serem combatidos pela metodologia *lean* são: defeitos (dispensação incorreta), tempo de espera, tempo de transporte, estoque descompensado, movimentos excessivos para a realização de uma ou uma sequência de atividades, processamento excessivo (etapas desnecessárias), superprodução e desperdício de habilidades

(profissional com uma habilidade que poderia melhorar o seu tempo de processo, mas ele está em uma mesa grampeando papéis).

Para colocar a metodologia em prática é preciso seguir cinco princípios:

a. Identificar o valor: isso significa que você precisa identificar os seus clientes, o que eles querem, o que você entrega e se está atendendo as necessidades do cliente;

b. Mapear o fluxo de valor: o mapeamento de fluxo de valor é realizado por diversas metodologias, procure e escolha a que você melhor se adapta, só não esqueça que todos devem entender o que representou;

c. Criar fluxo contínuo: o fluxo das atividades se torna eficiente de modo que durante o processo não há acúmulo de tarefas/ subprodutos ou pessoas ociosas;

d. Estabelecer uma produção puxada: O cliente cria a necessidade, pede, e há a produção. Por exemplo, no sistema de dose unitária o medicamento unitarizado é dispensado porque aquele paciente precisou, caso contrário não deve ser levado a enfermaria do setor;

e. Procurar perfeição: a procura da perfeição é o que os japoneses chamam de *kaizen*, ou seja, melhoria contínua. Os profissionais não devem se acomodar. Devem seguir sugerindo novas ideias para a melhoria do processo. Conta-se que na fábrica da Toyota os funcionários ficavam, voluntariamente, após o horário de trabalho discutindo e expondo ideias livremente para a melhoria das atividades da fábrica. Esse cenário é interessante de ser analisado por meio da perspectiva de união e sensação de pertencimento que aqueles funcionários tinham com a fábrica.

Ao longo do tempo à metodologia lean foi incorporado o método Six Sigma ou Seis Sigmas. Ele é empregado para melhorar a qualidade, identificando e removendo defeitos em um determinado processo e eliminando a variabilidade. Os seis sigmas referem-se ao valor estatístico de seis desvios padrão, ou seja, a produção é 99,9997% correta. Ou seja, six sigma é uma análise estatística para verificar as inconformidades que significaria um erro a cada um milhão de produtos. De modo geral, a maneira de estabelecer os parâmetros de erro resumem-se a três desvios padrão.

Já, o nosso velho conhecido PDCA tem em sua etapa de planejamento a identificação das partes interessadas (stakeholders), a criação de uma equipe de melhoria, a compreensão das lacunas nos atuais processos e na qualidade, o desenvolvimento de uma intervenção de melhoria e medidas adequadas de sucesso, para, então, em seguida, implementar a intervenção (Malagón-Londoño, 2019).

SAIBA MAIS:

Cases de sucesso que empregaram princípios lean podem ser encontrados na mídia. O Hospital Leforte, por exemplo, conseguiu diminuir custos e melhorar os tempos de atendimento após aplicar os princípios lean pronto-socorro e no centro cirúrgico das unidades da Liberdade e do Morumbi (São Paulo capital). Veja o relato em:



<http://bit.ly/2Prm5bs>

Estudos acadêmicos provenientes de graduações, especializações, mestrado e doutorado promovem o conhecimento e estimulam que as organizações estudadas adotem os formatos concluídos. O redesenho dos processos e do layout das farmácias hospitalares ganham destaque para o nosso objetivo. Veja exemplos em:

<http://bit.ly/2Prm5bs>

<http://bit.ly/2Toj4B8>

O emprego das técnicas lean e de outras ferramentas de melhora de processo promove uma maior eficiência do serviço prestado, além de valorizar os profissionais que passam a realizar atividades que tem excelência na execução. Dessa forma, evitam ou diminuem os desperdícios mencionados. Poderia dizer que se essas ferramentas fossem música, para mim seria assim: o lean não é meu namorado, mas poderia ser.

Tecnologia da Informação e farmácia hospitalar

A tecnologia da informação é aliada dos serviços de farmácia sob vários aspectos. De forma que é um componente essencial na prestação de cuidados ao paciente e tem sido dificultado devido ao aumento na quantidade de dados a gerenciar, no número de profissionais que controlam os processos e nas demandas para acesso em tempo real.

Devido a necessidade de aprofundamento de estudo a farmacoinformática se tornou um ramo da especialização da Farmácia cujo primeiro registro foi datado de 1993. Contudo, somente em 2003 foi fundado na Índia um centro nacional de estudos. No Brasil, esse segmento da profissão farmacêutica ainda não está consolidado e poucos profissionais se especializam na área.

A farmacoinformática é definida como o campo da ciência que estuda dados e informações sobre o uso de medicamentos em um determinado sistema de saúde. O sistema de informação em farmácia como suporte para automação é vital para otimizar a segurança e eficiência do processo de medicação.

Esses sistemas não devem ser considerados como uma ameaça ao emprego dos profissionais, mas como uma oportunidade de executar tarefas mentais. Isto é, a automação não reduz a necessidade de recursos humanos. Essa força de trabalho deve ser treinada e realocada visto que as necessidades não deixam de existir, sendo apenas modificadas.

Há diversos softwares com as mais variadas características. A preocupação do profissional farmacêutico envolvido no processo de escolha e implantação do software devem ser suas funcionalidades - desde o gerenciamento de estoque até a prescrição, a administração e o monitoramento do uso dos medicamentos.

Essencialmente esse sistema deve apresentar um módulo de gerenciamento de estoque, módulo de prescrição eletrônica, dispensação, administração e monitorização. O gerenciamento de estoque deve permitir o cadastro, os cálculos financeiros, cálculos de estoque e cálculos para a programação de compra.

Sobre o módulo de prescrição médica eletrônica, Cavallini e Bisson (2010) nos alertam que:

“Estudos epidemiológicos indicam que muitos erros com medicamentos se relacionam às prescrições de medicamentos e que as estratégias para prevenção desses erros devem basear-se no desenvolvimento e na implantação de um sistema informatizado de prescrição médica eletrônica.”

As vantagens da adoção de um sistema para prescrição eletrônica são: segurança da recepção da correta mensagem pela enfermagem e farmácia, facilidade de armazenar dados, diminuição do tempo e de erros relacionados a medicamentos. Esse sistema pode ser otimizado se por meio dele o prescritor tenha acesso a lista de medicamentos e produtos para saúde e informações sobre reações adversas e interações entre medicamentos e entre medicamento e nutriente.

A presença da informatização não se dá apenas pela utilização de softwares, mas também da automação. Os processos internos as farmácias apresentam lógicas que permitem a execução de tarefas por máquinas e que, por meio delas, tornem o processo mais rápido e seguros, para o manipulador e para o paciente.

A automação da unitarização e fracionamento deve seguir os princípios determinados pela RDC n. 67. São exemplos de maquinário:

- Sistemas unidose (helpmed), Auto-print ii (Grifols), os quais separam comprimidos, um a um, em embalagens com códigos de barras, nome do produto, lote, validade e o que mais for necessário. um processo automático que embala até 120 comprimidos/minuto

- Sistemas como Sharp SxTM (care fusion) e Opus 30x (Opus System) são capazes de individualizar ampolas, garantindo a identificação adequada

- Repeater pump (Baxa) bombeia soluções com alta precisão, podendo ser utilizado para envase e fracionamento de líquidos orais, injetáveis e semissólidos, automação do fracionamento

A automação da identificação e rastreabilidade promove maior segurança na dispensação e administração de medicamentos. São exemplos de modos de rastreabilidade:

- códigos lineares (EAN13 e GS1-128)
- códigos bidimensionais (dataBar e data Matrix)
- Etiquetas magnéticas
- Etiquetas de identificação por radiofrequência (radio frequency identification – RFID)

O modelo data matrix é o mais recomendável por apresentar a maior capacidade e possibilidade de programar diferentes variáveis.



SAIBA MAIS:

Em 2014, o Hospital Sírio-Libanês ganhou o título de apresentar a primeira farmácia hospitalar 100% automatizada.
<http://bit.ly/2v3W0lx>

Da reportagem contida no item saiba mais, um parágrafo ganha destaque:

"O Software dos sistemas PillPick e BoxPicker será integrado ao sistema de prescrições já existente no hospital, estando previsto para resultar em uma redução de aproximadamente 70% na operação manual dos medicamentos na farmácia e, ao mesmo tempo, ampliando o controle e rastreabilidade do processo. Para garantia do sucesso do projeto, uma equipe multidisciplinar, formada por farmacêuticos, gestores de suprimento, enfermeiros, especialistas em TI, além de engenheiros e arquitetos do HSL. A combinação das várias tecnologias na logística de medicamentos e materiais visa proporcionar mais segurança no processo de atendimento aos pacientes."

Outra interessante forma de automação é o emprego de robôs para o armazenamento e controle de estoque. Ao exemplo do, também, sistema Opus – Opuspick que embala toda a medicação necessária para o paciente e pode ser usado para o abastecimento das farmácias satélites como da enfermaria. Também, o equipamento Consis.E Robot e Pyxis (BD) que armazenam e dispensam o medicamento solicitado, assim como os equipamentos Rowa que armazenam e dispensam medicamentos de maneira unitarizada.



SAIBA MAIS:

Quer saber mais sobre o assunto, entre no link e descubra curiosidades sobre a automatização em farmácia.
<http://bit.ly/2v3W0lx>

Outro tipo de automação que é interessante e favorece a estabilidade dos medicamentos é a automação do sistema de monitoramento dos parâmetros ambientais da farmácia. Esse tipo de monitoramento e seu registro é obrigatório pelas vigilâncias sanitárias a fim de garantir as condições ideais de temperatura e umidade para os produtos estocados.

Esse tipo de automatização promove agilidade nos processos de registros, a redução do trabalho manual e de papel gerado, assim como a extinção de falhas humanas. Alguns dos sistemas que é capaz de realizar esse tipo de monitorização são o Incoterm, o LabWatch e o Vaisala viewLinc.

Por fim, analisando os exemplos dados vários tipos de tecnologia estão disponíveis às instituições de saúde pública e privada. As soluções variam do custo zero a um determinado valor que deve ser encarado como um investimento, já que a prevenção dos desperdícios pagará, ao longo do tempo, o dinheiro gasto. Além disso, o gestor deve ter consciência de que a tecnologia é um diferencial competitivo, e que entenda as limitações de tratar esse assunto em setores exclusivamente administrativos.

Aprendendo a gerir processos e qualidade: identificação de erros



INTRODUÇÃO:

Olá pessoal! Nessa competência mudaremos o nosso olhar sobre o serviço de farmácia como um profissional da saúde, iremos enxergar como um gestor investigativo que irá empregar a gestão por processos e da qualidade para melhorar a eficiência da farmácia hospitalar. Iremos aprender o que é importante para uma gestão de excelência. Assim, o objetivo dessa competência é que você, ao final dela, consiga enxergar racionalmente as tarefas para uma tomada de decisão correta. Dessa forma, beneficiando os seus clientes – demais profissionais de saúde e paciente, e seus colegas de farmácia, já que transformará as atividades mais seguras e eficazes. Vamos lá?

Gestão por processos

As atividades de gestão segundo a SBRAFH devem abranger o estabelecimento da missão, visão e valores; do organograma; formulação, implementação e acompanhamento do planejamento estratégico; estabelecimento de indicadores e seu monitoramento; provimento do corpo funcional capacitado e adequadamente dimensionado; estabelecimento das atribuições e responsabilidades; promoção da educação continuada; elaborações e revisões de procedimentos operacionais padrão, fluxograma, etc.; gerenciamento do estoque e do desempenho financeiro; e, o estabelecimento e promoção de estratégias para a melhoria contínua da qualidade. E é para promover continuamente a qualidade que conheceremos a gestão por processos e da qualidade.

A gestão por processos é um modelo de gestão como sendo o enfoque sistêmico de projetar e melhorar continuamente os processos organizacionais, por pessoas potencializadas e trabalhando em equipe, combinando capacidades tecnológicas e emergentes, objetivando a entrega de valor ao cliente. A gestão de processos visa à melhoria contínua dos processos, com o intuito de agregar maior valor ao cliente.

Seus objetivos ou princípios são:

- aumentar o valor do produto/serviço na percepção do cliente;
- aumentar a competitividade;
- atuar segundo a(s) estratégia(s) competitiva(s) considerada(s) mais relevante(s), que agregue(m) valor ao cliente;
- aumentar sensivelmente a produtividade, com eficiência e eficácia;
- simplificar processos, condensando e/ou eliminando atividades que não acrescentem valor ao cliente.

É importante que você entenda que valor no contexto da gestão por processos não é o valor monetário; mas, sim, a experiência que o cliente espera daquilo que está contratando. Por exemplo, quando vou a um restaurante de renome e que cobra acima da média eu espero que eu não precise esperar para ter uma mesa para ficar com a minha família, espero que a música não esteja muito alta para que possamos conversar, que o maitre e os garçons sejam gentis e prestativos, que a comida não demore muito a chegar e que quando chegar a comida

esteja bem apresentada, quente e deliciosa. É mais ou menos como a brincadeira de expectativa versus realidade. Se a sua expectativa é alta, você estará disposto a pagar um valor maior para aquele produto ou serviço que considera de qualidade. Se sua expectativa é baixa e o custo alto, provavelmente você não irá adquirir pois seu cérebro já está condicionado a acreditar que aquilo é ruim/má qualidade.

Dessa forma é fácil concluir que o cliente deve estar sempre no centro de suas atenções. Alguns autores acreditam que haja clientes externos e clientes internos. Os clientes externos é o seu cliente principal, o que irá receber de fato o produto ou serviço. Muitas vezes pode haver mais de um cliente externo. Por exemplo: Pai acompanha o filho em uma consulta – o filho é quem de fato irá ser atendido, mas é o pai que tem poder monetário para pagar para produto ou serviço. O cliente interno, por sua vez, são todos aqueles que estão trabalhando no processo e que tem alguma expectativa sobre ele.

Outros autores, por sua vez, acreditam que o único cliente é o final, ou seja, esses autores acreditam que a visão holística do processo é mais importante que a análise do que algum cliente interno possa querer.

Mas, o que é processo? Processo é uma sequência de atividades/ operações ordenadas de forma lógica que apresentam entradas e saídas, que ocorrem ao longo de um período, sendo executado por pessoas ou máquinas, e que tem como objetivo a entrega de um produto ou serviço para aquele que solicitou a sua execução, com objetivo de cumprir um objetivo ou meta. Outra definição e processos pode ser "processo é qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e gera uma saída (output) para um cliente interno ou externo".

Os processos podem ser classificados em primários (ou essenciais), de suporte e de gestão.

Os processos Primários são processos ponta a ponta, multifuncionais, que direcionam as entregas de valor aos clientes. São também denominados como processos de núcleo ou essenciais, pois representam as atividades essenciais que a organização desempenha para cumprir sua missão.

Esses processos constituem a cadeia de valor que cada etapa soma à etapa precedente, medida pela sua contribuição para a criação ou entrega de um produto ou serviço aos clientes.

Os processos de Suporte são estruturados de forma a dar suporte aos processos primários, gerenciando recursos e/ou infraestrutura requerida pelos processos primários. A principal diferença entre processos primários e de suporte é que os processos de suporte não entregam diretamente o valor aos clientes, enquanto os processos primários o fazem. Processos de suporte podem ser críticos e estratégicos para as organizações, na medida em que permitem à organização efetivamente executar os processos primários.

Processos de Gestão são processos usados para medir, monitorar e controlar atividades de negócios, garantindo que um processo primário ou um processo de suporte atinjam metas operacionais, financeiras, reguladoras e legais. Esses processos não conferem valor diretamente aos clientes, mas são necessários a fim de garantir que a organização opere com eficiência e eficácia.

Para conhecê-los mais profundamente necessita-se realizar a modelagem de processos. A modelagem tem a função de identificar, mapear, analisar e redesenhar os processos.

O objetivo da modelagem de processos pode ser definido como: melhor compreensão do funcionamento de uma organização; usar e explicitar o conhecimento adquirido e a experiência para usos futuros (lições aprendidas); otimizar o fluxo de informações; reestruturar a organização (aspecto funcional, comportamental, estrutural, entre outros), controlando-a e coordenando-a.

Para mapear processos é aconselhável:

- Escolher uma parte do todo que possa ser reconhecível um começo um meio e um fim, por exemplo: processo de unitarização de medicamentos e não a recepção dos medicamentos até a monitorização do paciente. A escolha do processo deve ser realizada por meio de métodos, quando já não forem previamente selecionados. Uma alternativa é a utilização da matriz de impacto x severidade, outros podem ser avaliação da importância dos processos X, Y, Z para a consistência com a estratégia, impacto na organização, contém atividade que comprometa o desempenho global e o custo;

- Mapear o processo sabendo que indicadores empregará para medir os resultados;
- Que as informações representadas em forma de fluxograma ou mapa devem ser simples, facilmente compreensíveis por qualquer um até quem não esteja inserido naquele meio;
- Engaje seus colegas, pois precisará de informações deles, como o tempo para a execução da atividade;
- Escolha uma notação para representar as suas informações;
- Selecione uma ferramenta para execução.

A sequência de etapas para o mapeamento de processos são:

- a. Projeto: momento inicial em que se planeja qual método, meta-modelo, notação e ferramenta será utilizado;
- b. Modelagem: quando se dá o entendimento do processo e das suas documentações, identifica-se atividades passíveis de automação, verifica pontos críticos em que incidem ou tem uma maior possibilidade de ocorrer erros, e se definem sistemas de apoio ou retaguarda;
- c. Simulação: momento em que cenários são simulados para verificar qual deles apresenta os melhores resultados para o atingimento do objetivo;
- d. Execução: implantação do processo
- e. Monitoramento: Acompanhamento do processo para verificar pontos que necessitem ajustes;
- f. Melhoria: ideias, inovações ou mudanças que são implantadas no processo para aumentar a eficácia.

A análise do processo pode ser realizada de forma contínua pelo BPM ou desencadeadas por fatores específicos, como informações provenientes do planejamento estratégico, de indicadores de desempenho de novas tecnologias etc. As principais práticas que possam ser utilizadas para melhoria do processo são (Reijersa e Mansarb, 2005).

Tabela 2: Melhores práticas para a melhoria de processos.

Elemento	Prática	Descrição	Comentários
Cliente (melhoria de contato)	Realocação de controle	Redirecionar as operações de verificação e reconciliação para o próprio cliente.	Risco de fraude.
	Redução do contato	Reduzir o tempo e número de contatos com o cliente.	Reduz a possibilidade de erros e espera, mas o cliente pode receber uma grande quantidade de dados de uma só vez.
	Integração	Integração do processo ou parte dele ao processo do cliente.	Utilização do conceito de integração da rede de suprimentos aos processos.
Processo (visão operacional)	Direcionamento do pedido	Definir a necessidade do pedido ser processado pelo processo atual ou por um novo processo.	Isso pode resultar num acréscimo de atividades de coordenação.
	Eliminação de tarefas	Eliminação de tarefas que não agregam valor ou são redundantes.	Leva a uma redução do tempo de processamento e custo.
	Forma de trabalhar os pedidos	Considerar a possibilidade de remover o processamento em lotes ou de modo periódico.	O processamento em lotes ou periódico de um pedido pode gerar atrasos ou demora para o cliente. Deve-se avaliar a possibilidade de processar os pedidos individualmente ou operar o processo continuamente, sem interrupções. Risco de aumentar o custo da operação.
	Triagem	Considerar a divisão de uma tarefa maior em duas ou mais tarefas alternativas ou a integração de duas ou mais tarefas alternativas em uma.	Exemplo: a existência de diferentes caixas no supermercado (rápido, preferencial, normal).
	Composição de tarefas	Combinar pequenas tarefas em uma única ou dividir uma grande tarefa em menores.	A combinação de pequenas tarefas em uma maior pode levar a redução de set-up. Pode ser entendida como uma triagem.

Processo (ponto de vista de sua ordem)	Ressequenciamento	Mover a tarefa para locais mais apropriados.	Mudança do local de execução possibilita que seja feita próxima de tarefas semelhantes.
	Knock-out	Uma típica fase de um processo consiste na verificação de várias condições que devem ser atendidas para se obter um resultado positivo. Caso uma condição não seja atendida chega-se ao Knock-out.	Se existe liberdade para checar as várias condições, torna-se interessante iniciar a checagem daquelas condições mais problemáticas e fáceis de se verificar. Pode ser visto como tipo especial de ressequenciamento.
	Paralelismo	Considerar a possibilidade de executar algumas tarefas em paralelo.	O tempo de processamento diminui. Pode ser visto como tipo especial de ressequenciamento.
	Exceção	Projetar o processo para os pedidos típicos e isolar os pedidos especiais que fogem do fluxo normal.	As exceções são tratadas à parte. Isso torna o processo mais eficiente.
Organização – estrutural	Designação por pedido	Deixar os funcionários com o maior número possível de tarefas de um dado pedido.	A qualidade do serviço tende a melhorar.
	Designação flexível	Alocar os recursos de modo que a máxima flexibilidade seja preservada no curto prazo.	Se a tarefa pode ser realizada por dois funcionários, aloque para o funcionário mais especializado, deixando livre o funcionário mais flexível.
	Centralização	Tratar os recursos dispersos geograficamente como se fossem centralizados.	Possibilitar melhor utilização dos recursos.
	Separe as responsabilidades	Evite designar responsabilidades às pessoas de diferentes áreas funcionais.	Quando as responsabilidades estão difusas em diferentes áreas, podem ser fonte de conflito ou negligência.
	Equipe do cliente	Considere a designação de pessoas de diferentes áreas que se dedicarão a um conjunto específico de pedidos.	Pode ser vista como uma variação da Designação por Pedido.
	Ação numérica	Minimizar o número de departamentos, grupos ou pessoas envolvidas no processo.	Diminui os problemas de coordenação.
	Gerente	Designar uma pessoa (gerente) responsável por lidar com cada tipo de pedido ou cliente.	O gerente torna-se o ponto de contato entre o cliente e o processo.

Organização – população	Recursos extras	Se a capacidade não for suficiente, considere o aumento de recursos.	Contraria a prática da ação numérica.
	Especialista – Generalista	Considere seus recursos serem especializados ou generalistas	Leva a transformar generalistas em especialistas ou vice-versa.
	Empower	Dar aos trabalhadores maior poder de decisão, reduzindo também a quantidade de pessoas na média gerência.	Elimina grande parte do tempo dedicado à solicitação de autorização.
Informação	Adição de controles	Verifica os insumos e os produtos antes de enviar ao cliente.	Busca a melhoria da qualidade.
	Buffering	Mantém a informação necessária armazenada possibilitando seu rápido acesso.	Pode ser oneroso para a empresa.
Tecnologia	Automatização da tarefa	Resulta na automatização das tarefas.	Custo de automatização pode ser alto.
	Nova tecnologia	Melhorar as restrições físicas utilizando uma nova tecnologia no processo.	Alto custo de implementação.

Fonte: Reijersa e Mansarb, 2005

Por fim, devemos lembrar que ao analisar o processo, além das análises dos indicadores, deve-se ter em mente as perdas segundo a filosofia lean:

- Superprodução
- Tempo de espera
- Transporte
- Processo
- Estoque
- Movimentação
- Produto defeituoso

São esses desperdícios e os indicadores de desempenho que norteiam a identificação dos erros no processo.

A partir da modelagem do processo do serviço farmacêutico é possível identificar mais facilmente onde os erros se iniciam e o que se pode fazer para solucioná-los de modo a aumentar a segurança para o paciente, diminuindo tempo e melhorando a margem de lucro da instituição hospitalar.

**RESUMINDO:**

E, aí? Conseguiu aprender tudinho? Nessa competência descobrimos o que é gestão de processos, o que é um processo e o que é de que forma elaborar um mapeamento de processos. Aprendemos que o mapeamento facilita entender a ordenação lógica das atividades, quais são os pontos críticos e os indicadores de desempenho. O conhecimento desses dados permite uma tomada de decisão com mais certeza para a prevenção e combate de erros. Legal, não é? Até a próxima!

Aprendendo a gerir processos e qualidade: ferramentas e soluções

**INTRODUÇÃO:**

Olá! Firme, aí? Nessa competência conheceremos o que significa ser um gestor da qualidade e qual a importância da gestão da qualidade para o serviço de farmácia. A qualidade em serviços pode ser encarada como a entrega de valor ao cliente que supra ou supere as suas expectativas.

O que é qualidade?

Qualidade é um termo subjetivo que pode ter a sua definição modificada de pessoa para pessoa ou ao longo do tempo. A qualidade pode ser verificada/medida em um produto ou serviço levando-se em conta vários elementos: desempenho, características, confiabilidade, durabilidade, utilidade, resposta, estética e reputação (OLIVEIRA, 2014).

Qualidade é o "conjunto das características de um produto ou serviço que lhe conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas. Numa situação contratual ou regulamentada, tal como no campo da segurança nuclear, as necessidades são especificadas, enquanto noutros domínios é preciso identificar e definir as necessidades implícitas" (LOBO, 2010).

De uma forma geral, para o nosso entendimento, qualidade é um conjunto de características inerentes e a sua conformidade a determinados requisitos e que atende ao propósito para o qual foi feito/realizado.

Controle x Garantia x Gestão

Esses três termos são empregados juntos a palavra qualidade, mas qual a diferença? Primeiro, o que é inspeção da qualidade?

"Conjunto de atividades tais como medir, examinar, ensaiar ou verificar uma ou mais características de uma entidade, e comparar os resultados com os requisitos especificados de modo a determinar se a conformidade é obtida para cada uma dessas características" (LOBO, 2010).

Controle da qualidade é a verificação das características de um produto ou serviço às suas especificações pré-definidas ou normatizadas.

O controle da qualidade é o "conjunto das técnicas e atividades de caráter operacional utilizadas para satisfazer os requisitos da qualidade. O controle da qualidade envolve técnicas e atividades de caráter operacional com os objetivos de acompanhar (monitorar) processos e eliminar as causas de deficiências em todas as fases do ciclo da qualidade de modo a atingir eficácia econômica" (LOBO, 2010).

Garantia da qualidade é um termo mãos amplo que o controle da qualidade, e abrange não somente um ponto de verificação, mas vai desde a qualidade da concepção do serviço ou produto passando pela produção até o pós-venda. É o conjunto de todas as atividades planejadas e sistematicamente implementadas no âmbito do sistema da qualidade, necessárias para garantir que uma entidade está em condições de satisfazer os requisitos da qualidade. A garantia da qualidade visa tanto objetivos internos (para a organização) como externos (cumprir situações contratuais ou necessidades do cliente) (LOBO, 2010).

Gestão da Qualidade é definido como o planejamento e gerenciamento de todas as atividades de um processo visando estabelecer, manter e melhorar a qualidade de um produto ou serviço, mantendo a viabilidade econômica do empreendimento e a satisfação do cliente.

"Todas as atividades da função geral da gestão que determinam a política da qualidade, os objetivos e as responsabilidades, e os implementam por meios como o planejamento da qualidade, o controle da qualidade, a garantia e a melhoria da qualidade, no âmbito do sistema da qualidade. A gestão da qualidade é responsabilidade de todos os níveis da gestão, mas deve ser conduzida e implementada pela gestão de topo. Ela dá atenção aos aspectos econômicos" (LOBO, 2010).

A gestão da qualidade como estratégia parte do princípio de que o ciclo do serviço ou produto leva a uma contínua identificação de novos requisitos e necessidades.

A melhoria do desempenho de processos pode ser obtida a partir de duas abordagens: melhoria contínua e melhoria radical. A melhoria contínua é uma abordagem para a melhoria que se caracteriza como um processo de contínuo aperfeiçoamento de produtos e processos na direção de grandes melhorias de desempenho. Por sua vez, melhoria radical pressupõe uma mudança radical no conceito ou projeto do produto ou processo. Geralmente essa abordagem implica em grandes investimentos como a compra de um maquinário antes inexistente.

O método mais simples para a gestão da qualidade é o emprego do ciclo PDCA: Planejamento (plan)- identificação do problema, investigação de causas raízes, proposição e planejamento de soluções; Execução (do)- preparação (treinamento) e execução das tarefas de acordo com o planejado; Verificação (check) - coleta de dados e comparação do resultado alcançado com a meta planejada; Ação (act): atuação sobre os desvios observados para corrigi-los.

**VOCÊ SABIA:**

A expressão gerenciamento de riscos refere-se às ações preventivas e corretivas para os desvios de qualidade detectados.

Outro método, que é uma versão mais detalhada do PDCA, é o Método de Análise e Solução de Problemas (MASP). Suas etapas são: 1.identificação do problema e priorização dos problemas; 2.observação: problema para aumentar a chance de se identificarem as causas do problema; 3.análise: nessa fase, busca-se levantar as causas raízes ou fundamentais do problema em questão; 4.plano de ação; 5.ação: consiste na implementação do plano de ação; 6.verificação; 7.padronização: visa introduzir as ações implementadas na rotina de operação do processo ou atividade; 8.conclusão: registro de todas as ações.

Sendo que, paralelamente as 4 fases do ciclo PDCA, as etapas de 1 a 4 compõem a fase planejamento; a 5 e a 6, respectivamente, são relativas as etapas de execução e verificações; e, por fim, a 7 e 8, a etapa de ação.

O processo de gestão da qualidade é composto pelas etapas de identificação dos problemas prioritários; observação e coleta de dados; análise e busca de causas-raízes; planejamento e implementação das ações; verificação dos resultados.

Para acompanhar a qualidade de um processo são empregadas ferramentas. As 7 ferramentas da qualidade tradicionais são: estratificação; folha de verificação; gráfico de Pareto; diagrama de causa e efeito; histograma; diagrama de dispersão; gráfico de controle. Já, as ferramentas gerenciais da qualidade são: diagrama de relações; diagrama de afinidades; diagrama em árvore; matriz de priorização; matriz de relações; diagrama de processo decisório (Process Decision Program Chart); diagrama de atividades (diagrama de flechas).

De modo didático, Carpinetti (2016) apresenta cada ferramenta já relacionada à sua finalidade. Confira!

Tabela 3: Principais finalidade e ferramentas de avaliação ou gestão

Finalidade	Ferramenta
Identificação e priorização de problemas	Amostragem e estratificação
	Folha de verificação
	Histograma, medidas de locação e variância
	Gráfico de Pareto
	Gráfico de tendência, gráfico de controle
	Mapeamento de processo
	Matriz de priorização
	Estratificação
	Diagrama espinha de peixe
	Diagrama de afinidades
	Diagrama de relações
	Relatório das três gerações (passado, presente, futuro)
Elaboração e implementação de soluções	Diagrama árvore
	Diagrama de processo decisório
	5W1H
	5S
Verificação de resultados	Amostragem e estratificação
	Folha de verificação
	Histograma, medidas de locação e variância
	Gráfico de Pareto
	Gráfico de tendência, gráfico de controle

Fonte: Carpinetti, 2016.

O Ministério da Saúde a mais de 10 anos estimula a melhoria da qualidade nos serviços de saúde por meio do programa Proqualis que oferece cursos e materiais sobre a implantação de ferramentas da qualidade na gerência em saúde. Além disso, é importante lembrar o alerta do início da Portaria n. 4283/2010, do Ministério da Saúde, o gerenciamento inadequado e o uso incorreto de medicamentos e de outras tecnologias em saúde acarretam sérios problemas à sociedade, ao SUS, e às instituições privadas, gerando aumento da morbimortalidade, elevação dos custos diretos e indiretos, e prejuízos à segurança e à qualidade de vida dos usuários.

Por meio dessa portaria foram estabelecidos diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. Isso significa uma preocupação efetiva do Ministério da Saúde com a qualidade do serviço farmacêutico oferecida em estabelecimentos de saúde, no Brasil

As diretrizes apresentam elementos necessários à efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população, otimizando resultados clínicos, econômicos e aqueles relacionados à qualidade de vida dos usuários.



SAIBA MAIS:

Para saber mais sobre gestão da qualidade e suas ferramentas, acesse:

<http://bit.ly/2Vky4T>

<http://bit.ly/2w6hyUM>

<http://bit.ly/2TfFRaJ>

<http://bit.ly/3chi2bw>

Como uma forma de demonstrar a qualificação dos processos, hospitais tem buscado acreditações. O CRF/SP (2019) explica que isso não é só não só como forma de introduzir a cultura de qualidade na instituição, como também para oferecer um diferencial no atendimento aos clientes/pacientes.

A acreditação é um sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde, voluntário, periódico e reservado, por meio de padrões previamente estabelecidos. Os padrões podem ser mais simples ou mais exigentes, por exemplo, o padrão six sigma é um padrão exigente.

Essa acreditação é o estabelecimento em seus processos de uma política de qualidade posta por organizações como Organização Nacional de Acreditação (ONA), o Programa de Controle da Qualidade Hospitalar (CQH), o Prêmio Nacional de Gestão em Saúde (PNGS), Joint Commission International – JCI (internacional), Qmentum International Accreditation Program (Canadá) e National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations – NIAHO (Noruega).

Segundo o CRF/SP (2019) as principais vantagens da acreditação são: Segurança para os pacientes e profissionais; Qualidade da assistência; Construção de equipe multidisciplinar; útil instrumento de gerenciamento; O caminho para a melhoria contínua; Credibilidade junto à população; Gerenciamento por indicadores.

Percebeu como a acreditação entra em consonância com o discutimos nessa competência? A diferença é que na acreditação é a organização acreditadora que irá fixar quais os padrões de qualidade a serem seguidos.

Assim, terminamos a nossa jornada pela gestão da qualidade. Não se esquece que o esforço que você tem agora para implantar a gestão por processos e da qualidade, terá retorno em um processo para efetivo e fluido, diminuindo, posteriormente, o seu trabalho.

RESUMINDO:



E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo desta unidade letiva, vamos resumir tudo o que vimos. Nesta Unidade Letiva você teve a oportunidade de compreender a etapa de distribuição e dispensação de medicamentos, conheceu tecnologias para a melhoria do processo e aprendeu sobre gestão por processos de da qualidade. Assim vamos nos despedindo! Não se esqueça: Não há gerência sem métrica!

BIBLIOGRAFIA

ALLEN, L. V.; et al. Introdução à farmácia de Remington Porto Alegre: Artmed, 2016.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 20 anos do SUS. Legislação. Disponível em: <http://bit.ly/2Shd86v>

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília: Ministério da Saúde, 2 ed., 2006.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia Básico para Farmácia Hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. Disponível em: <http://bit.ly/390Bckk>

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. Resolução 338, de 06 de maio de 2004. Disponível em: <http://bit.ly/2Z8VogO>

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n. 4283, de 30 de dezembro de 2010. Aprova as diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. Disponível em: <http://bit.ly/39W3DPY>

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência Farmacêutica: instruções técnicas para a sua organização. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boas práticas para estocagem de medicamentos. Brasília: Central de Medicamentos, 1989. Disponível em: <http://bit.ly/2PnitqQ>

BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Orientações para conselheiros de saúde. Brasília: TCU, 2 ed., 2015.

CARPINETTI, L. C. R. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. São Paulo: Atlas, 3 ed.

CARVALHO, F. D. et al. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, habilidades e atitudes. São Paulo: Manole, 2014.

CAVALLINI, M. E.; BISSON, M. P. Farmácia Hospitalar: um enfoque em sistemas de saúde. São Paulo: Manole, 2 ed., 2010.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRF/SP). Farmácia Hospitalar. São Paulo: Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, 4 ed., 2019.

DANTAS, S. C. C. Farmácia e Controle das Infecções Hospitalares. Pharmacia Brasileira, n 80, fev./mar., 2011. Disponível em: <http://bit.ly/2Sa3G54>

JULIANI, R. G. M. Organização e funcionamento de farmácia hospitalar. São Paulo: Érica, 2014.

MÁLAGÓN-LONDOÑO, G. et al. Gestão Hospitalar para uma administração eficaz. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 4 ed., 2019.

REIJERSA, H.A., MANSARB, S. L. Best practices in business process redesign: an overview and qualitative evaluation of successful redesign heuristics. Ômega, V. 33, p. 283-306, 2005.

SALU, E. J. Administração Hospitalar no Brasil. São Paulo: Manole, 2013.

SIMONETTI, V.M.M.; et al. Gestão de suprimentos da farmácia hospitalar com a implantação de métodos gerenciais de insumos utilizados na manufatura. Revista Eletrônica Produção Engenharia, v.2, n.1, p. 57-68. jan.-jul., 2009.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR (SBRAFH). Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar. São Paulo: SBRAFH, 3 ed., 2017. Disponível em: <http://bit.ly/2EIJTl2>

